آموزش و یادگیری در پرستاری

فرآیند آموزش به مددجو: مبانی نظری و کاربرد بالینی

۱۱
اصل یادگیری

۵
مرحله فرآیند آموزش

۳
حیطه یادگیری

فهرست مطالب

نقشه راه جلسه — چهار بخش اصلی از نظریه تا کاربرد بالینی

بخش اول — ۰۱

مبانی آموزش بهداشت

مقدمه، ضرورت و اهمیت آموزش در نظام سلامت

بخش دوم — ۰۲

نظریه یادگیری

تعاریف، ماهیت، اصول و عوامل مؤثر بر یادگیری

بخش سوم — ۰۳

آموزش به بیمار

تعاریف، فرآیند ۵ مرحله‌ای و روش‌های تدریس بالینی

بخش چهارم — ۰۴

ارزشیابی و چالش‌ها

موانع یادگیری، ارزشیابی بالینی و چک‌لیست کاربردی

۰۱

بخش اول

۰۱/۰۴

مبانی آموزش بهداشت

ضرورت، اهمیت و جایگاه آموزش در نظام سلامت

ضرورت آموزش بهداشت در قرن حاضر

بخش ۱ — مبانی آموزش بهداشت

در نظام سلامت معاصر، عوامل متعددی آموزش بهداشت را به یک مؤلفه حیاتی تبدیل کرده است. تغییر الگوهای بیماری از حاد به مزمن، افزایش هزینه‌های درمان و تأکید بر توانمندسازی بیمار، نقش پرستار را از مراقب صرف به آموزش‌گر تخصصی ارتقا داده است.



۰۱
اولویت حفظ سلامتی بر درمان
رویکرد نوین سلامت: prevention > cure

۰۲
کاهش مدت بستری و خروج زودتر بیمار
آموزش مؤثر، زمان ترخیص را کاهش می‌دهد

۰۳
افزایش بیماری‌های مزمن
مدیریت بلندمدت — CKD ،دیابت، فشار خون

۰۴
انتظار جامعه از پرستار به عنوان مرجع بهداشتی
پرستار نزدیک‌ترین مرجع آموزشی به بیمار

۰۵
کارکرد چهارگانه: پیشگیری، درمانی، توانبخشی، ارتقاء سلامت
آموزش در هر چهار حوزه نقش محوری دارد

آموزش بیمار در عدد و رقم

داده‌های کلیدی از اثربخشی آموزش در پرستاری

۶۰٪ کاهش بازپذیرستانی

آموزش مناسب پیش از ترخیص، بازگشت به بیمارستان را تا ۶۰٪ کاهش می‌دهد.

۳× افزایش پایبندی به درمان

بیمارانی که آموزش ساختارافته دریافت می‌کنند، سه برابر بیشتر به برنامه درمانی پایبند می‌شوند.

۸۰٪ بیماری‌های مزمن

بیش از ۸۰٪ هزینه‌های سلامت به بیماری‌های مزمن مربوط است که آموزش نقش محوری در مدیریت آن‌ها دارد.

۵۰٪ خطاهای دارویی

آموزش صحیح مصرف دارو، خطاهای دارویی سرپایی را تا نصف کاهش می‌دهد.

منبع: WHO Patient Safety Reports 2023 و مطالعات Nursing Education

۰۲

بخش دوم

۰۲ / ۰۴

نظریه یادگیری

مفاهیم بنیادی، ماهیت، اصول و عوامل مؤثر بر یادگیری

یادگیری چیست؟

سه نگاه نظری به ماهیت یادگیری

یادگیری فرآیندی است که در طی آن فرد از طریق تجربه، تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار و توان رفتاری خود ایجاد می‌کند. نظریه‌پردازان مختلف از زوایای متفاوت به این مفهوم نگاه کرده‌اند.

۱

نگاه اول

فرهنگ لغت

«کسب دانش از روی شوق»

یادگیری ناشی از اشتیاق درونی فرد برای دانستن است؛ تعریفی سنتی و عاطفی از ماهیت یادگیری.

تعریف سنتی

۲

نگاه دوم

نظریه گشتالت

«کسب بینش جدید یا تغییر در بینش‌های گذشته»

یادگیری باز organisation کلی اطلاعات و درک ناگهانی روابط بین اجزا است؛ یادگیری به مثابه بینش.

بینش‌محور

۳

نگاه سوم — مرجع

هلیگارد و مارکوئیز

«فرآیند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده، مشروط بر اینکه در اثر تجربه و بینش باشد و ناشی از عوامل فیزیولوژیک نباشد.»

جامع‌ترین تعریف علمی و تعریف مرجع در ادبیات پرستاری.

تعریف مرجع پرستاری

سه مؤلفه کلیدی در تعریف یادگیری

تمایز یادگیری از سایر تغییرات رفتاری

بر اساس تعریف علمی، یادگیری دارای سه مؤلفه اساسی است که تمایز آن را از تغییرات دیگر رفتاری مشخص می‌کند.

مؤلفه ۱

تغییر

یادگیری منجر به تغییر می‌شود. پس از کسب تجربه، فرد نسبت به قبل حالت جدیدی پیدا می‌کند. میزان تغییر از ساده (یادگیری شماره تلفن) تا پیچیده (راندن دوچرخه یا مهارت تزریق) متغیر است.

از ساده تا پیچیده

۱

مؤلفه ۲

نسبتاً پایدار

تغییر باید نسبتاً پایدار باشد. تغییرات ناشی از عوامل انگیزشی، هیجانی، انطباق حسی، رشد و بلوغ یا خستگی به سرعت از بین می‌روند و یادگیری محسوب نمی‌شوند.

پایداری در زمان

۲

مؤلفه ۳

رفتار بالقوه

یادگیری یک نوع توانایی در فرد ایجاد می‌کند، نه صرفاً تغییر در رفتار ظاهری. گاهی این توانایی‌ها مدتی پنهان می‌مانند (رفتار بالقوه) و در زمان مناسب بروز می‌کنند.

پنهان تا بروز

۳

یادگیری: فرآیند مستمر و مبتنی بر تجربه

دو ویژگی بنیادی یادگیری که آن را از سایر تغییرات رفتاری متمایز می‌کند:

کارت ۱

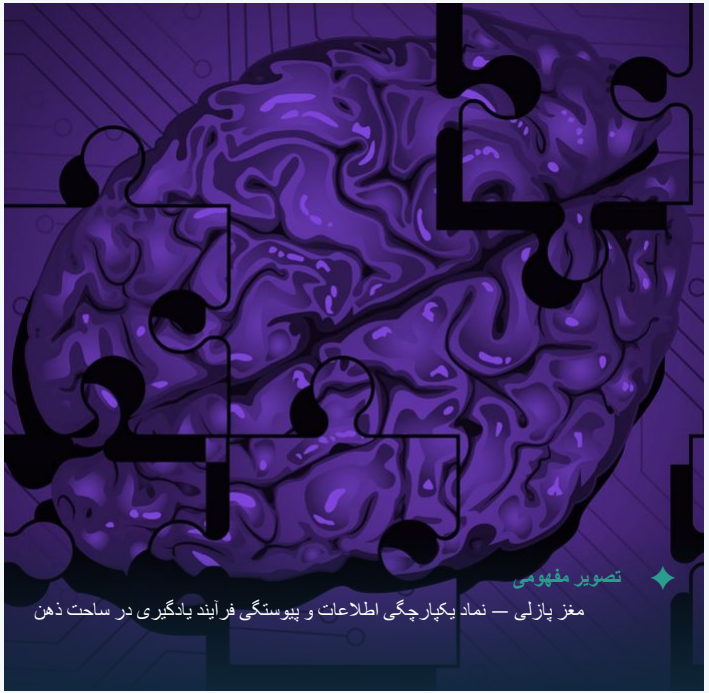
فرآیند مستمر

یادگیری یک فرآیند است؛ یعنی بر وقایع و روابط پویا، مستمر و پیوسته و در حال تغییر اطلاق می‌شود. یادگیری از طریق تعامل دائم فرد با محیط، همیشه و در همه جا به صورت پیوسته و مستمر صورت می‌گیرد. این ویژگی نشان می‌دهد آموزش یک رویداد یک‌باره نیست.

کارت ۲

مبتنی بر تجربه

تغییر یادگیری باید در اثر تجربه باشد، نه عوامل فیزیولوژیک. تجربه شامل محرک‌های بیرونی (مطالعه، گوش دادن به سخنرانی، زمین خوردن کودک) و محرک‌های درونی (فکر کردن درباره یک مطلب) است. عوامل غیرتجربی مانند مصرف دارو، بلوغ، پیری یا ورزش کردن، یادگیری محسوب نمی‌شوند.



تصویر مفهومی

مغز پازلی — نماد یکپارچگی اطلاعات و پیوستگی فرآیند یادگیری در ساحت ذهن

یادگیری فرآیندی پویاست — نه یک رویداد یک‌باره. تجربه، نه دارو یا بلوغ، موتور محرک آن است.

آموزش چیست؟

«آموزش فعالیت آگاهانه و از پیش طراحی شده‌ای است که با هدف آسان کردن فرآیند یادگیری انجام می‌شود. آموزش یک فرآیند ارتباطی است که منجر به ارتقاء یادگیری می‌شود.»

فرهنگ لغت — ۱

تعریف سنتی

«پرورش دادن، تربیت کردن، رشد دادن ذهن، شخصیت و جسم به وسیله ضوابط طراحی شده.»

براون و اتکینس — ۲

تعریف مدرن مبتنی بر یادگیرنده

«فراهم آوردن فرصت‌هایی برای یادگیری فراگیران.»

تعریف جامع — ۳

تعریف کاربردی

«هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طراحی شده با هدف آسان کردن فرآیند یادگیری؛ شامل مجموعه تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده با هدف دستیابی به اهداف آموزشی.»

تعریف سنتی · تعریف مدرن · تعریف کاربردی

چهار ویژگی کلیدی آموزش

- فرآیند ارتباطی
- پاسخ به نیاز فراگیر
- نیاز به ارتباط معلم-یادگیرنده
- فعالیت آگاهانه

آموزش در برابر یادگیری

آموزش و یادگیری دو فرآیند مستقل اما مرتبط به هم هستند. درک تفاوت آن‌ها برای طراحی آموزش مؤثر ضروری است.

یادگیری
فرآیند درونی — LEARNING

- معطوف به یادگیرنده ☻
- فعالیتی از سوی یادگیرنده ✦
- می‌تواند غیرفعال یا اتفاقی باشد ✦
- هدف نهایی است⚑
- در مغز فرد رخ می‌دهد▦
- غیرقابل مشاهده مستقیم⊘

VS

آموزش
فرآیند بیرونی — TEACHING

- معطوف به معلم/پرستار ✚
- فعالیتی از سوی معلم ◗
- فرآیندی آگاهانه و طراحی‌شده ❄
- وسیله رسیدن به هدف؟
- در تعامل رخ می‌دهد ✦
- همیشه به یادگیری ختم نمی‌شود⊖

یادگیری هدف است و آموزش وسیله رسیدن به آن هدف — آموزش موفق زمانی است که به یادگیری منجر شود.

مراحل فرآوری یادگیری

یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که اطلاعات دریافتی این چهار مرحله را به ترتیب طی کنند. هر مرحله برای یادگیری پایدار ضروری است و اختلال در هر یک، کل فرآیند را مختل می‌کند.

۱

مرحله ۱

فراگرفتن

Acquisition

کسب اطلاعات از طریق حواس و ادراک. این مرحله پایه یادگیری است.

۲

مرحله ۲

نگهداری

Retention

به یادسپاری و ذخیره‌سازی اطلاعات در حافظه کوتاه‌مدت و بلندمدت مغز.

۳

مرحله ۳

یادآوری

Recall

شامل دو بخش: بازشناسی (تشخیص آشنایی مطلب) و بازخوانی (فراخوانی کامل از حافظه).

۴

مرحله ۴

بازتولید

Reproduction

تبدیل یادگیری به رفتار قابل مشاهده. این مرحله در آموزش بالینی حیاتی است.

هر گونه اختلال در این زنجیره منجر به یادگیری ناقص یا عدم یادگیری می‌شود.

اصول یازده‌گانه یادگیری در پرستاری

این اصول بر اساس نظریه‌های یادگیری بزرگانی چون پیاژه، اسکینر و باندورا تدوین شده‌اند و در طراحی برنامه آموزش بیمار کاربرد مستقیم دارند.

۰۱
۱
یادگیری مبتنی بر نیاز فراگیر، تأثیر بیشتری دارد.

۰۲
۲
یادگیرنده باید به پاداش برسد (تشویق).

۰۳
۳
مفاهیم بنیادی باید اول فرا گرفته شوند.

۰۴
۴
موارد یادگیری به صورت جزء به کل بیان شوند.

۰۵
۵
موارد جدید در ارتباط با آموخته‌های قبلی باشند.

۰۶
۶
یادگیری از آنچه فراگیرنده فعلاً قادر است انجام دهد شروع شود.

۰۷
۷
موارد یادگیری برای یادگیرنده واضح باشند.

۰۸
۸
یادگیری بلافاصله مورد استفاده قرار گیرد.

۰۹
۹
مشارکت فعال یادگیرنده ضروری است.

۱۰
۱۰
یادگیری بیشتر از طریق مکانیسم تداعی معانی صورت می‌گیرد.

۱۱
۱۱
یادگیری با تکرار تقویت می‌شود.

الگوی کاربردی

این ۱۱ اصل، چارچوب طراحی هر جلسه آموزش بیمار را تشکیل می‌دهند.

عوامل مؤثر بر یادگیری

پنج عامل کلیدی بر فرآیند یادگیری تأثیر می‌گذارند. شناسایی و کنترل این عوامل توسط پرستار، پیش‌نیاز طراحی آموزش مؤثر است.

عامل ۱ ★ عامل محوری

آمادگی

آمادگی یادگیرنده در سه بُعد: روحی، جسمی و فیزیکی، عاطفی. پرستار باید قبل از شروع آموزش، این سه بُعد را ارزیابی کند.

- **روحی** — آرامش و تمرکز
- **جسمی و فیزیکی** — بدون درد، خستگی یا تب
- **عاطفی** — پذیرش موقعیت

عامل ۲

انگیزه و هدف

محور حرکت یادگیرنده. بدون انگیزه، آموزش تأثیری ندارد.

عامل ۳

تجارب قبلی

دانش و مهارت‌های پیشین، پایه یادگیری جدید را تشکیل می‌دهند.

عامل ۴

محیط فیزیکی

نور، تهویه، دما، امکانات آموزشی و سروصدا.

عامل ۵

روش تدریس

تناسب روش با محتوا، یادگیرنده و هدف آموزشی.

موانع یادگیری در بیمار

موانع عمومی — ناشی از وضعیت بیمار

عامل کلیدی ۴

فشار جسمی و روشی بیمار موجب کاهش دامنه توجه و کاهش ظرفیت یادگیری می‌شود. **درد، اضطراب، خستگی و داروهای آرام‌بخش** از مهم‌ترین موانع هستند.

گاهی خود پرستار مانع است

مورد ۸

موانع ناشی از عملکرد پرستار در فرآیند آموزش

۰۱ بررسی نامناسب آمادگی بیمار

۰۲ برنامه‌ریزی نامناسب زمان آموزش

۰۳ ارائه محتوا با شتاب و عجله

۰۴ عدم تفهیم مطالب (زبان پیچیده)

۰۵ عدم ارتباط دادن مطالب به هم

۰۶ بیان متناقض اطلاعات

۰۷ عدم بازخورد مناسب به بیمار

۰۸ عدم ارزشیابی میانی و پایانی

شناسایی و رفع این موانع، پیش‌نیاز آموزش مؤثر است.

— بخش سوم —

۰۳ / ۰۴
آموزش به بیمار

فرآیند ۵ مرحله‌ای، روش‌های تدریس بالینی و حیطه‌های یادگیری

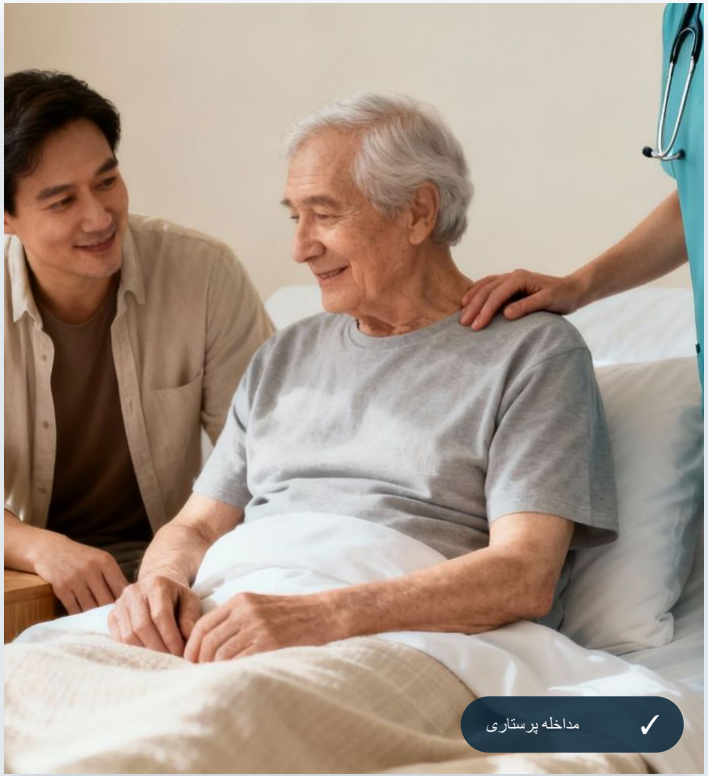
آموزش به بیمار چیست؟

تعریف

آموزش به بیمار عبارت است از استفاده از فرآیند آموزشی برای افراد، خانواده‌ها و سایر اشخاص در رابطه با چهار حوزه: پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی. این آموزش به بیماران و اطرافیان کمک می‌کند تا با تغییرات حاصله در وضعیت سلامتی‌شان سازگاری پیدا کنند و به سلامت مطلوب دست یابند.

جمع‌بندی

در واقع، آموزش به بیمار مداخله‌ای پرستاری است که بیمار و خانواده را برای مشارکت فعال در فرآیند درمان و مراقبت خود توانمند می‌سازد. این مداخله در چهار حوزه پیشگیرانه، تشخیصی، درمانی و توانبخشی کاربرد دارد.



پیشگیری | تشخیص | درمان | بازتوانی

فرآیند آموزش به بیمار: مدل ۵ مرحله‌ای

آموزش به بیمار با بررسی نیاز بیمار و آمادگی وی آغاز شده، با طراحی فعالیت‌هایی که تغییر رفتاری و شناختی ایجاد می‌کنند ادامه می‌یابد و به ارزشیابی ختم می‌شود. این چرخه در صورت نیاز تکرار می‌شود.

۱

بررسی نیازهای یادگیری — گام اول

شناسایی شکاف بین دانش/مهارت فعلی و مورد نیاز. از طریق سؤال مستقیم، مشاهده رفتار بیمار و ارتباط در حین مداخله.

۲

بررسی انگیزشی — گام دوم

ارزیابی آمادگی روحی، عاطفی و جسمی بیمار. بدون انگیزه، آموزش موفق نخواهد بود.

۳

تدوین اهداف و تشخیص — گام سوم

بیان آنچه بیمار باید یاد بگیرد به صورت اهداف واقع‌بینانه و قابل دستیابی.

۴

روش تدریس-یادگیری — گام چهارم

انتخاب روش مناسب بر اساس حیطه یادگیری (شناختی، عاطفی، روانی-حرکتی).

۵

ارزشیابی و بازطراحی — گام پنجم

تعیین وقوع تغییر رفتاری مورد نظر و در صورت لزوم، بازطراحی برنامه آموزشی.

مراحل ۱ و ۲ — نیازسنجی و انگیزش

۰۱ شناسایی نیازهای یادگیری — گام اول

اولین و حیاتی‌ترین مرحله. نیاز واقعی بیمار ممکن است با نیاز درک‌شده متفاوت باشد.

سؤالات مستقیم

مثال: هنگام عکس‌برداری چه اتفاقی می‌افتد؟ چگونه کودک خود را شستشو می‌دهید؟

مشاهده مستقیم

مثال: مشاهده خشکی و ترک پوست پای بیمار دیابتی نشان‌دهنده نیاز به آموزش مراقبت از پا است.

در طی ارتباط / مداخله

شناسایی نیاز در حین انجام کار پرستاری؛ مثل متوجه شدن عدم مهارت در استفاده از اسپایرومتر.

ممکن است بیمار از نیاز خود آگاهی نداشته باشد — نقش پرستار بیدار کردن این آگاهی است.

۰۲ بررسی انگیزش — گام دوم

بدون توجه به انگیزه و جلب علاقه یادگیرنده، آموزش موفق نخواهد بود.

متقاعدسازی بیمار

مدرس باید جهت متقاعد کردن بیماران نیازمند به یادگیری بکوشد.

علل فقدان انگیزه

فقدان انگیزه می‌تواند ناشی از: اشکال در سازگاری با بیماری / اختلاف عقیده و سیستم ارزشی / تفاوت در درک مفاهیم سلامتی و بیماری.

پیش‌نیازهای آمادگی

آمادگی افراد به زمینه آموزش قبلی، توانایی ذهنی و نگرشی جهت قبول مسئولیت بستگی دارد.

انگیزش پویاست — باید در طول فرآیند آموزش بازسازی شود.

مراحل ۳ و ۴ — اهداف و حیطه‌های یادگیری

.اهداف یادگیری باید به صورت واقع‌بینانه و قابل دستیابی تدوین شوند و در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی طبقه‌بندی می‌شوند. مدرس در هر سه حیطه مطالب آموزشی را فراهم می‌کند

حیطه شناختی Cognitive

.درک ذهنی بیمار از بیماری و درمان خود

مثال بالینی

چگونگی تأثیر دیابت بر بدن — بیمار مکانیسم افزایش قند خون و .اثر آن بر اعصاب، کلیه و چشم را توضیح می‌دهد

حیطه عاطفی Affective

.نگرش و پذیرش بیماری توسط بیمار

مثال بالینی

قبول بیماری و مسئولیت‌پذیری جهت مراقبت از خود — بیمار .اهمیت پایش روزانه قند خون را می‌پذیرد و به آن عمل می‌کند

حیطه روانی-حرکتی Psychomotor

.مهارت‌های عملی و حرکتی بیمار

مثال بالینی

مهارت‌های عملی چون تزریق انسولین، استفاده از گلوکومتر، یا .تغییر پانسمان — بیمار با تکنیک استریل تزریق را انجام می‌دهد

:روش‌های تدریس

- رسانه‌های نوشتاری و سمعی-بصری (بروشور، ویدیو)
- سخنرانی و بحث (توضیح تعاملی)
- نمایش روش انجام کار (demonstration)
- گروه‌های یادگیری (گروه دیابتی، گروه سرطان)

— بخش چهارم —

۰۴ / ۰۴

ارزشیابی و چالش‌ها

ارزشیابی بالینی یادگیری، چک‌لیست کاربردی و جمع‌بندی

ارزشیابی یادگیری و چک‌لیست بالینی

ارزشیابی

ارزشیابی تعیین می‌کند که آیا تغییر رفتاری مورد نظر ایجاد شده یا خیر. این مرحله توسط مشاهده رفتار بیمار و یا سؤالات شفاهی و کتبی صورت می‌گیرد. ارزشیابی هم فرآیند و هم محصول را شامل می‌شود.

روش ارزشیابی ۳

- **مشاهده رفتار (return demonstration)**
  مثل تزریق توسط بیمار
- **سؤالات شفاهی**
  پرسش از بیمار درباره داروها
- **پرسشنامه / کتبی**
  برای آموزش‌های پیچیده‌تر

چک‌لیست ۷ گام آموزش مؤثر به بیمار — ابزار بالینی

1. نیاز یادگیری را از ۳ مسیر شناسایی کن (سؤال، مشاهده، ارتباط)۱
2. آمادگی جسمی، روحی و عاطفی بیمار را ارزیابی کن۲
3. اهداف را به زبان ساده و قابل اندازه‌گیری تنظیم کن۳
4. محیط آموزش را از سروصدا و عوامل حواس‌پرتی پاک کن۴
5. روش تدریس را با حیطه یادگیری منطبق کن۵
6. مشارکت فعال بیمار را ترغیب کن۶
7. بازخورد فوری بده و در پایان ارزشیابی کن۷

آموزش مؤثر به بیمار، مداخله‌ای است که با نیازسنجی آغاز، با ارزشیابی پایان می‌یابد و با تکرار، به تغییر رفتار پایدار منجر می‌شود. نقش پرستار، تسهیل‌گر این تغییر است.